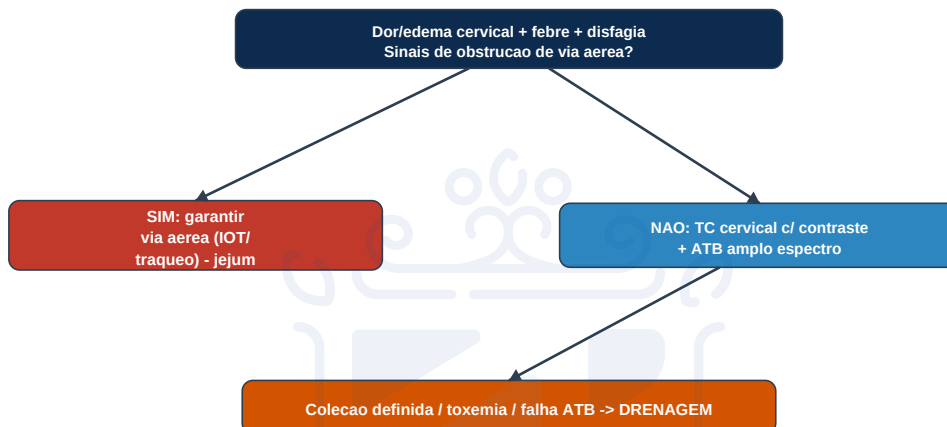


ABSCESSO CERVICAL — VIA AÉREA E DRENAGEM

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

ABSCESSO CERVICAL — VIA AÉREA PRIMEIRO



DEFINIÇÃO E ESPAÇOS

O QUE É

- Coleção de pus nos planos cervicais (profundos ou superficiais) por infecção bacteriana
- Origem: odontogênica, amigdaliana, trauma, corpo estranho, contiguidade ou hematogênica
- Espaços: submandibular/sublingual, parafaríngeo, retrofaríngeo, pré-vertebral, carotídeo
- Distinção crítica: CELULITE (fase inicial, sem coleção) x ABSCESSO (coleção purulenta delimitada -> drenar)

QUANDO SUSPEITAR

MANIFESTAÇÕES TÍPICAS

- Dor cervical intensa (frequentemente unilateral), edema, rubor e calor local
- Febre, mal-estar e sinais sistêmicos
- Disfagia, odinofagia, voz abafada, trismo
- Flutuação à palpação (coleção definida)
- Casos graves: dispneia, estridor (via aérea comprometida)

RED FLAGS — ALERTA IMEDIATO

VIA AÉREA E COMPLICAÇÕES GRAVES

- Sinais de obstrução de via aérea / estridor / dificuldade para deglutir a própria saliva
- Taquipneia, hipoxemia; sinais de sepse ou choque
- Complicações: mediastinite descendente, Síndrome de Lemierre (trombose séptica da jugular)
- Erosão vascular, osteomielite mandibular, fístula cervical
- Qualquer comprometimento de via aérea = urgência absoluta (assegurar via aérea ANTES de imagem)

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

EXAMES

- Laboratório: hemograma (leucocitose com desvio), PCR/VHS, função renal, eletrólitos
- Hemoculturas antes do antibiótico, quando possível
- TC de pescoço COM CONTRASTE = padrão-ouro (localiza coleção, extensão, relação com via aérea/vasos)
- USG cervical: útil em coleções superficiais ou para guiar punção
- RM em casos selecionados (suspeita de envolvimento neurovascular)
- Diferencial: linfadenite, tumores, cistos congênitos (branquial/tireoglossos), infecção viral

SUORTE INICIAL E VIA AÉREA

Rx PRIMEIROS PASSOS

1. Garantir via aérea patente — PRIORIDADE (sinais de obstrução: considerar IOT; se falhar/inviável -> traqueostomia)
2. Jejum (NPO) até estabilização / via aérea assegurada
3. Monitorização contínua em emergência ou UTI
4. Acesso IV, hidratação, correção de distúrbios eletrolíticos
5. Avaliação contínua antes, durante e após procedimentos

ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA (aeróbios + anaeróbios orais)

Esquema	Detalhe / observação
Vancomicina + Piperacilina-tazobactam	Vanco 15-20 mg/kg IV 8-12h + Pipe-tazo 4,5g IV 6-8h
Vancomicina + Meropenem	Vanco + Meropenem 1g IV 8/8h
Vanco + Ceftriaxona + Metronidazol	Ceftriaxona 1-2g/dia + Metronidazol 500mg IV 8/8h
Clindamicina + Piperacilina-tazobactam	Alternativa (cobertura anaeróbia/MRSA, alergias)

DRENAGEM CIRÚRGICA

INDICAÇÕES

- Abscesso claramente delimitado em imagem
- Sinais de toxemia sistêmica
- Falha clínica após 24-48h de antibioticoterapia adequada
- Coleções grandes, múltiplas ou com risco de extensão profunda
- Técnica: incisão e drenagem ampla em centro cirúrgico + coleta de cultura (aeróbia/anaeróbia)
- ATB em geral 7-14 dias (ajustar conforme evolução e cultura)

MONITORIZAÇÃO E SEGUIMENTO

ACOMPANHAR

- ☐ Avaliação clínica diária + trabalho respiratório/via aérea
- ☐ Controle dos drenos (volume e aspecto)
- ☐ Exames seriados (hemograma, PCR)
- ☐ Reavaliar imagem se não houver melhora
- ☐ Tratar o foco primário (dentário/amigdaliano) assim que possível

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA (SAMU)

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com abscesso cervical (espaço ____), febre + disfagia/trismo. Via aérea: ____ (pérvia/IOT/traqueo).
- TC cervical com contraste: coleção em ____; relação com via aérea/vasos: ____.
- ATB empírico iniciado às ____; drenagem indicada: sim/não.
- Solicito UTI móvel / vaga em serviço com cirurgia de cabeça e pescoço (via aérea instável = urgência).



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com abscesso cervical e estridor, dificuldade para deglutir a própria saliva e queda de saturação. Qual a prioridade?

- A) Solicitar TC e aguardar antes de qualquer medida
- B) Garantir a via aérea (IOT ou, se falhar, traqueostomia) antes da imagem
- C) Iniciar apenas antibiótico e observar
- D) Drenagem ambulatorial imediata sem via aérea
- E) Alta com antibiótico oral

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual exame de imagem é o padrão-ouro para localizar e avaliar a extensão de um abscesso cervical profundo?

- A) Radiografia simples de pescoço
- B) Tomografia de pescoço com contraste
- C) Ultrassonografia apenas
- D) Ressonância sem contraste de rotina
- E) Cintilografia

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual achado distingue ABSCESSO de CELULITE cervical e indica drenagem?

- A) Presença de febre
- B) Coleção purulenta delimitada (flutuação/imagem)
- C) Dor à deglutição
- D) Leucocitose
- E) Edema difuso sem coleção

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Complicação grave do abscesso cervical caracterizada por trombose séptica da veia jugular interna é a:

- A) Síndrome de Lemierre
- B) Síndrome de Horner
- C) Síndrome de Eagle
- D) Síndrome de Ramsay-Hunt
- E) Síndrome de Sjögren

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Quando está indicada a drenagem cirúrgica no abscesso cervical?

- A) Sempre, antes do antibiótico
- B) Coleção delimitada em imagem, toxemia sistêmica ou falha clínica após 24-48h de ATB adequada
- C) Apenas após 14 dias de antibiótico
- D) Somente se houver mediastinite
- E) Nunca, o tratamento é exclusivamente clínico

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

No abscesso cervical com sinais de obstrução (estridor, sialorreia, dessaturação), a prioridade absoluta é assegurar a via aérea (IOT; traqueostomia se falhar), ANTES de exames de imagem. Via aérea instável é urgência.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A TC de pescoço com contraste é o padrão-ouro: localiza a coleção, define a extensão e a relação com a via aérea e os grandes vasos, orientando a drenagem. USG ajuda em coleções superficiais.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A coleção purulenta delimitada (flutuação ao exame ou coleção na imagem) distingue o abscesso da celulite (fase inicial sem coleção) e é o que indica drenagem cirúrgica.

QUESTÃO 4 → Resposta: A

A Síndrome de Lemierre é a tromboflebite séptica da veia jugular interna, complicação grave de infecções orofaríngeas/cervicais (clássico: *Fusobacterium necrophorum*), com êmbolos sépticos pulmonares.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Drena-se o abscesso cervical quando há coleção delimitada na imagem, toxemia sistêmica, falha após 24-48h de ATB adequada, ou coleções grandes/múltiplas com risco de extensão. Antibiótico isolado não basta na coleção.

SM24
Suporte ao Plantão Médico